DOCUMENTO 02 DE 04 · EQUIPE CHEERS

O núcleo

A tese, a 7ª dimensão do ASSTI, os **quatro gaps** empilhados, o mecanismo da proposta e o impacto honesto que dá para prometer.

DOCUMENTO

02 de 04 — O núcleo

Leitura: 12 minutos

BASE

VigIndústria Brasil 2026 (p. 16, 21, 95, 98, 100, 110–119)

Regulamento 2026 · Anexo I

DOCUMENTO 02

O que está neste documento

Este é o documento que a gente **leva para a banca**. Ele responde: qual é a lacuna, por que ela é do tema, como a proposta a resolve ponta a ponta e — o mais importante — **o que dá para prometer e o que não dá**.

1 A tese em uma frase 3
E por que ela não pode ser invalidada pelo reveal de 13/11

2 A 7ª dimensão do ASSTI 4
Declarada, nunca analisada, e a segunda mais bem validada do instrumento

3 Gap 1 · De dimensão 5
As 4 dimensões do Anexo I × o que o instrumento mede — e os zero itens

4 Gap 2 · De ciclo 6
A cadeia de 7 elos: onde a predição funciona e onde ninguém olha

5 Gap 3 · De decisão 7
33 indicadores que não dizem "aqui está o foco" e nunca são medidos de novo

6 Gap 4 · De incumbente 9
Quem ocupa o espaço hoje e por que nenhum deles resolve

7 O mecanismo, em três passos 10
Trabalhador → posto → empresa, e as 4 pontas do sistema

8 A ponta de regulação 11
Cada restrição do regulamento, transformada em argumento

9 A 7ª dimensão operacionalizada 12
Os 6 itens, a pergunta literal e as regras do instrumento

10 O dia a dia 13
Seis momentos de um dia de trabalho — é o que a banca vê na demo

11 O impacto honesto 14
5 níveis de confiança, e a base científica que sustenta 2 das 3 alavancas

12 O que fica fora — e por quê 15
4 cortes explícitos, o steelman do agrotech e a resposta curta

13 Resumo em 4 linhas 17
O que a gente diz se perguntarem "resuma"

TRÊS REGRAS QUE VALEM PARA TODO ESTE DOCUMENTO

1. Todo número leva fonte — página e tabela. **2.** Não prometer economia: em ensaio randomizado (n = 32.974) o ROI de absenteísmo é **−49%**. **3.** Não chamar de "manutenção preditiva" — o Anexo I rejeita essa leitura.

CAPÍTULO 1

A tese em uma frase

A TESE

O SESI mede o risco que o trabalhador corre, mas não mede o trabalho que causa o risco. A sétima dimensão do ASSTI — *fatores de redução da produtividade* — foi declarada e nunca analisada, e o questionário oficial não tem **nenhum** item de autonomia, participação ou propósito. A gente operacionaliza essa dimensão: o trabalhador responde 6 itens no celular, o agregado anônimo do posto vira um índice, e isso cruza com a exposição prevista para virar **3 alavancas priorizadas** para a empresa.

De onde ela vem — a lacuna está na fonte do tema, não no palpite

> *"Os resultados focalizam em **seis das sete dimensões** do Sistema de Avaliação em Saúde e Segurança do Trabalhador da Indústria — ASSTI (SESI, 2023), conforme ilustrado na Figura 1, a saber: (1) fatores demográficos; (2) fatores comportamentais; (3) bem-estar mental; (4) morbidade; (5) percepção de saúde e autocuidado; e, (6) cultura de segurança. **Não foram analisados, os fatores de redução da produtividade por não estarem alinhados ao propósito do presente estudo.**"*
>
> — VigIndústria Brasil 2026, p. 16

Isso é uma **lacuna declarada** — o relatório mais recente e mais completo do SESI sobre saúde do trabalhador diz, com todas as letras, que a 7ª dimensão ficou de fora. E o questionário que instrumentaliza o ASSTI (Anexo I do relatório, p. 110–119) não tem nenhum item que capture a dimensão que o Anexo I do **desafio** pede: participação, autonomia, propósito.

Por que isso não muda em 13/11

Nível	O que é	Quando	Muda?
1 · Tema	"Desafios e soluções para a **sustentabilidade dos modelos assistenciais de saúde**" (§2.1 + Anexo I)	Já está no regulamento	Não
2 · Desafio	As questões levantadas pelas empresas do Conecta Saúde 2026	13/11 (§7.3)	É revelado
3 · Direção	"as informações e direcionamentos necessários para o desenvolvimento das soluções"	13/11 (§7.3)	É revelado

O que muda em 13/11 é o núcleo da implementação, não a tese. A tese é uma lacuna do **tema**; o desafio é um **recorte** dentro do tema. Nenhum anúncio de desafio invalida uma lacuna declarada na fonte que dá nome ao tema. O que 13/11 faz é escolher **qual das 5 bifurcações** do kit a gente assume — e o escopo de 32 h se ajusta em 90 minutos.

E O ÚNICO CENÁRIO EM QUE A TESE MUDA

Se o desafio vier com recorte **fora de saúde do trabalhador** — saúde suplementar puro, ou uma frente de agro. Aí a bifurcação assume e o argumento institucional (PAO 2026 + canal Viva+) vira o plano B. Mas o **§7.2 continua mandando** em modelos assistenciais, e a lacuna da 4ª dimensão continua sendo do tema.

CAPÍTULO 2

A 7ª dimensão do ASSTI

Este é o achado que sustenta a proposta inteira. Não é uma interpretação nossa — é uma frase escrita no relatório e um número na página seguinte.

7
dimensões do ASSTI (SESI, 2023)

6
foram analisadas no VigIndústria

0
itens de participação, autonomia ou propósito (p. 110–119)

2ª
posição em consistência interna entre todas as dimensões (p. 21)

> *"...os fatores de cultura de segurança (CR = 0,975; AVE = 0,783), morbidade referida (CR = 0,902; AVE = 0,472) e **fatores de redução da produtividade (CR = 0,863; AVE = 0,581)** apresentaram os melhores indicadores de consistência interna, sendo que os fatores de cultura de segurança e os **fatores de redução da produtividade também apresentaram evidências satisfatórias de validade convergente (AVE > 0,50)**."*
>
> — VigIndústria Brasil 2026, p. 21

O PONTO QUE FECHA A TESE

Não é uma dimensão fraca. É a bateria completa, validada, que ninguém usou. O instrumento inteiro foi desenhado, piloto-testado e validado (CFI 0,973 · TLI 0,971 · RMSEA 0,060 · SRMR 0,130; teste-reteste PABAK > 0,7) — e a 7ª dimensão ficou fora do primeiro relatório porque "não estava alinhada ao propósito do presente estudo". Ou seja: ela existe, está validada, e **falta alguém querer medi-la**.

A verificação literal no questionário (p. 110–119)

Termo procurado no instrumento completo	Ocorrências	O que aparece, quando aparece
autonomia · autônomo · decisão · decidir · sugestão · engajamento	**0**	—
voz do trabalhador · propósito · confiança · segurança psicológica	**0**	—
participação	**2**	"participou de atividade de promoção da saúde?" e tempo de tela em redes sociais — nenhuma das duas é participação no trabalho

As duas grafias do nome — qual usar

Fonte	Como escreve	Nota
VigIndústria, p. 16	"Sistema de Avaliação em Saúde e Segurança do Trabalhador da Indústria"	**Use esta.** É o documento que a banca vai ler.
Caderno técnico, 2023	"Metodologia ASSTI (Avaliação de Saúde e Segurança em Trabalhadores da Indústria)"	É o caderno original. O ASSTI é sucessor do SAEVP (2010) e tem 3 índices: IGEV, IPRO, IPST.

E O RELATÓRIO PEDE EXATAMENTE O QUE O INSTRUMENTO NÃO MEDE

Na p. 98, o VigIndústria recomenda: "*orienta-se o **fortalecimento das competências de liderança para promover uma comunicação aberta e um ambiente psicologicamente seguro***"". Mas o questionário não tem **nenhum** item que meça ambiente psicologicamente seguro, autonomia ou participação. **A medição cobre risco, bem-estar, morbidade, autocuidado e cultura de segurança — e para no limite do que a empresa oferece. Não mede o que o trabalhador exerce.**

CAPÍTULO 3 · GAP 1 DE 4

Gap 1 · De dimensão

O Anexo I do desafio pede **quatro dimensões**. O instrumento oficial do SESI cobre três — e a quarta não tem nenhum item. Este é o gap que dá nome à proposta.

Dimensão (Anexo I)	Onde o VigIndústria mede	A lacuna
Comportamento	Bloco comportamental completo: álcool episódico pesado 34,2% · sedentarismo no lazer 44,3% · tempo de tela 33,9% · tabaco 6,5%	Mede, mas não **prioriza por recorte**. Nada no sistema diz "aqui está o foco desta empresa".
Ambiente	Percepção de ambiente seguro 71,4% · Insatisfação com as condições de trabalho 8,1%	Dois indicadores, e **nenhum ligando ambiente → desfecho de saúde**.
Organização do trabalho	Liderança 72,6% · Prevenção 70,2% · Treinamento 69,8% · Comunicação 65,6% · Estresse 20,3%	Indicadores de **cultura**, **nenhum de organização**: jornada, autonomia, carga, apoio social.
Participação das pessoas	**NENHUM INDICADOR**	**O instrumento não mede participação, autonomia, decisão, sugestão, propósito, confiança ou segurança psicológica.** Zero itens (p. 110–119).

Por que isso é um gap do **tema** e não do desafio

O Anexo I não diz "quatro dimensões que o instrumento deveria medir". Ele diz que a resposta não está em incorporar tecnologia, mas em **redesenhar os modelos assistenciais** — mais integrados, participativos e conectados às necessidades reais das pessoas e das organizações. E lista as quatro dimensões que precisam ser articuladas. A 4ª — **participação das pessoas**, com destino em autonomia, participação, bem-estar e senso de propósito — é exatamente a que o sistema de medição do SESI deixou em branco.

A REGRA DE OURO DA PROPOSTA

Não inventamos questionário. A 7ª dimensão do ASSTI já existe como construto validado pelo SESI, com a bateria completa e pronto. A nossa contribuição não é criar uma escala — é **torná-la operacional**: dar voz, agregar com privacidade (k ≥ 10) e converter em alavanca de decisão. Quem validar a proposta na banca vai ver que a base é do SESI, não nossa.

A LEITURA HONESTA DA PRÓPRIA BASE

O VigIndústria declara o próprio viés na p. 17: a amostra de conveniência — empresas que **voluntariamente** demandaram serviço ao SESI — "pode comprometer a representatividade". É o nosso principal contra-argumento e é nosso. A base é **transversal** (campo jul–dez/2025): **não há antes/depois**. E é exatamente por isso que o produto promete **medir** em vez de prometer resultado.

CAPÍTULO 4 · GAP 2 DE 4

Gap 2 · De ciclo

A cadeia de valor da saúde ocupacional tem **7 elos**. Os sistemas existentes olham o meio. Onde a predição funciona — antes do evento — quase ninguém olha.

1 · Presenteísmo
Trabalhar com dor, cansaço ou adoecimento sem faltar. **Não existe em sistema nenhum.**

→

2 · Exposição
O que o posto produz: ruído, carga, calor, agentes químicos, jornada. **Existe em base pública, mas só agregada.**

→

3 · Acidente
CAT, INSS, eSocial. **Instrumentado.**

→

4 · Afastamento
4,1 mi em 2025 (+17,1%). **Instrumentado.**

5 · Incapacidade
Permanente ou longa. **Instrumentado.**

→

6 · Saída
Desligamento, turnover, afastamento definitivo. **Instrumentado.**

→

7 · Resultado
Produtividade, margem, sustaining. **Só agregação nacional.**

ONDE A PREDIÇÃO FUNCIONA É ONDE QUASE NINGUÉM OLHA

A predição só funciona nos elos **1 e 2** — **antes** do evento. O elo 1 (presenteísmo) não existe em sistema nenhum: não há dado, não há indicador, não há produto. O elo 2 (exposição) existe em base pública, mas só agregada por CNAE × porte × região — nunca no nível do posto.

O que a gente instrumenta do MVP

Elo **2 (exposição prevista)** + elo **1 (a escuta do trabalhador sobre as condições que reduzem a capacidade de trabalhar)**. É por isso que o MVP não é "um app de check-in": é **uma janela que abre antes do afastamento**.

Por que o presenteísmo não está no MVP

O R$ 200–600 bi/ano do presenteísmo é fonte secundária **[a confirmar]** (IBEF-SP via AXENYA, 2024). E o R$ 468 bi (4% do PIB) é perda de produtividade por **doenças e acidentes de trabalho** — não do presenteísmo. Não vamos atribuir número a um elo que não temos dado.

O que muda em 13/11

Se o desafio vier sobre **interoperabilidade**, o export FHIR/RNDS vira o núcleo e a escuta vira caso de uso. Se vier sobre **exposição**, é o caso base. Se vier sobre **dashboard** (o cenário pior), reancoramos nas 4 dimensões.

O que a proposta entrega em termos de ciclo

Não um diagnóstico do passado — um **mecanismo de feedback** que fecha o ciclo: o trabalhador fala, o posto agrega, a empresa prioriza, e a intervenção é medida no ciclo seguinte. É a "continuidade de monitoramento sistemático" que o próprio VigIndústria pede na p. 100.

> *"A continuidade do **monitoramento sistemático por meio do VigIndústria será fundamental para validar a efetividade das intervenções** em andamento e, por conseguinte, a eventual necessidade de reorientá-las."*
>
> — VigIndústria Brasil 2026, p. 100

CAPÍTULO 5 · GAP 3 DE 4

Gap 3 · De decisão

O VigIndústria dá **33 indicadores** para **57.952 trabalhadores** em **825 empresas**. É um dado excelente. O que ele não dá é a resposta que o RH precisa: **"aqui está o foco desta empresa, e é isto que você faz na segunda-feira."**

33
indicadores com prevalência e IC 95%

1
onda — campo de jul–dez/2025, transversal

0
medições de antes/depois em todo o relatório

95%
de confiança, erro máximo de 2 p.p. — e sem desagregação por UF

Três coisas que o relatório não faz

Não prioriza

33 indicadores para toda a indústria. O RH recebe um relatório que descreve o Brasil do trabalho — e não o posto dele. **Priorizar exige comparar e decidir**, e o instrumento não foi feito para isso.

Não mede se a intervenção funcionou

Desenho transversal, de um tempo só. O próprio relatório pede continuidade de monitoramento (p. 100). **Não há antes/depois em lugar nenhum** — e sem antes/depois, nenhum programa de promoção de saúde se defende.

Não devolve nada acionável ao posto

A empresa recebe agregado. Não recebe "o que fazer". **E o painel da empresa é o mesmo formato para micro e para grande** — quando a micro precisa de uma ação de comunicação e a grande precisa de readequação ergonômica, o indicador é o mesmo.

A VIRADA QUE A PROPOSTA PROPÕE

Do indicador para a alavanca. O mesmo dado populacional, processado com **pesos à vista** e cruzado com a exposição prevista do posto, vira **3 alavancas priorizadas** — cada uma com o indicador nacional que a justifica. Não é um dashboard a mais: é a etapa que existe entre o diagnóstico e a ação.

As 3 alavancas e a evidência de cada uma

Alavanca	Evidência que a sustenta	Por que é acionável
1 · Reduzir a demanda no posto	Meta-análise em enfermagem: **demanda alta OR 1,57** (IC95% 1,04–2,36), significativo	Aponta onde mexer: jornada, demanda, ritmo
2 · Fortalecer o apoio de colegas e chefia	Meta-análise: **apoio no trabalho OR 0,58** (IC95% 0,41–0,83) — **reduziu** ausência	É intervenção de organização, não de bem-estar
3 · Comunicar prevenção de forma que chegue	65,6% consideram a comunicação **suficiente** (T36, p. 95) → **34,4%** não. Em micro e pequenas, só **56,2%** a acham suficiente	É a empresa-alvo do SESI-BA que está no gap

O CONTRAPESO HONESTO — E ELE É NOSSO

A mesma meta-análise achou **job strain OR 1,20 (IC95% 0,94–1,52), não significativo**, e controle OR 0,79 (0,55–1,12), também não significativo. E o próprio HSE reconhece o contraste: Demands, Relationships, Change e Role se associaram a ansiedade e depressão, mas **control e apoio entre pares não**. **Por isso a proposta fala em demanda e apoio — e não em "autonomia genérica".**

CAPÍTULO 6 · GAP 4 DE 4

Gap 4 · De incumbente

Não é que "não exista solução". Existe muita — e ela é ruim para o nosso caso. **Cada incumbent ocupa uma fatia e deixa o nosso gap aberto.**

Quem	O que faz	Por que não resolve o nosso gap
SESI · ASSTI + Viva+ o próprio SESI	Avaliação populacional do trabalhador, 7 dimensões, desde 2018	"Empresa só recebe agregado" — **não recebe nada acionável**. E a 7ª dimensão está morta dentro do próprio instrumento.
SOC · SGG · WOTY	Dashboard de SST + eSocial + PGR + COPSOQ	É **exatamente** o "dashboard de SST" que a nossa própria armadilha marca como valor incremental zero. Compliance, não participação.
bem.care · mywork · BlueService · Apdata	Contam a falta: atestado → folha	"Atestado = ausência, não saúde". **Contam a falta; ninguém cruza falta ↔ saúde ↔ população.** E a reclamação mais frequente do líder é não conseguir anexar atestado.
Onvida · Selven · DUO24h	Telemedicina B2B per capita	R$ 19,90–79,90/colaborador/mês. **Commodity.** Teleconsulta somada a app não é tese.
NRGuard · Benway · NR1Plus	COPSOQ/HSE + relatório IA + PGR	R$ 0–1.297/mês, com um player **gratuito e ilimitado**. Diagnóstico comoditizado.
500+ consultorias credenciadas SESI-BA	NR-1, PGR, laudos	R$ 15–80 mil, 4–12 semanas. **Entregam laudo** — a intervenção não é delas.
MEUSOC (do SOC)	App do trabalhador: 500 mil+ downloads	**O canal já existe** — mas o trabalhador adota o app *sobre ele*, não *dentro* do plano de cuidado. É o canal certo com a lógica errada.
Wellhub · Benevity · Afya	Rede de bem-estar e benefícios	**Fora do domínio.** "Ocupacional ≠ wellness". Não toca SST, ASO, PGR ou absenteísmo.

> **A FRASE QUE SERVE PARA A BANCA**
>
> Não vamos dizer "não existe solução". Vamos dizer: **"o canal existe, o dado existe, o diagnóstico existe e o laudo existe — mas são quatro produtos separados, e nenhum deles cruza a saúde do trabalhador com o trabalho que causa o risco. O elo que falta é o mesmo elo que o SESI declarou e nunca mediu."**

As 4 portas de entrada — as barreiras reais

Barreira	Intensidade	Por quê
Dados populacionais do ASSTI	Alta	Único dataset longitudinal de saúde do trabalhador na indústria — gerou o VigIndústria. E o indivíduo é dado sensível (LGPD).
Canal SESI	Alta	500+ credenciadas, 15 carretas, 26 DRs. Distribuição física e confiança institucional; entrada por edital.
Prova de resultado em saúde	Alta	Resultado é lento; comprador exige ROI e demo de 3 min.
Rede de clínicas (NR-7) + governança clínica	Média	Sem execução, o software não entrega cuidado. **Parecer simulado elimina a equipe** (armadilha 4).

CAPÍTULO 7

O mecanismo, em três passos

TRABALHADOR

6 itens offline · 90 s · opt-out por bloco · escala 1–5

Ele sai com as 2 alavancas que são dele.

→

POSTO / EMPRESA

Índice de contexto do posto (k ≥ 10, agregado anônimo)
+ índice de exposição prevista (CNAE × porte × região), pesos à vista

"Como o modelo funciona" aberto na tela.

→

RESULTADO

3 alavancas priorizadas, cada uma com o indicador nacional que a justifica

Dias expostos antes/depois · mudança organizacional observável

EM UMA FRASE

Um dispositivo de captura de sinal **em dois lados**: o trabalhador fala 6 itens num PWA instalável e offline; o agregado anônimo do posto cruza com um modelo de exposição previsto sobre bases públicas; e um motor de regras transparente traduz isso em 3 alavancas organizacionais com a evidência que as sustenta.

As 4 pontas do sistema — ponta a ponta

Ponta	Hoje	Resolução
Trabalhador	Fluxo: adoece → atestado → falta → o RH recebe uma folha. Ele **não é perguntado** sobre nada, e o plano de cuidado é montado **sobre** ele, sem ele.	Ele passa a **emitir sinal**: 6 itens, 90 s, offline, pode pular qualquer um — e recebe de volta as 2 alavancas que são dele. **A 4ª dimensão virando instrumento.**
Empresa / RH	Recebe um relatório com 33 indicadores e nenhum "aqui está o foco".	Recebe **3 alavancas priorizadas**, cada uma com o indicador nacional que a justifica — e o porquê do peso, à vista.
SESI	A plataforma de **2.738.306 vidas ativas** (Viva+) não tem esta camada de escuta.	É **módulo da Plataforma Viva+**, e o objetivo estratégico do **PAO 2026** é literalmente "promover a gestão integrada da saúde dos trabalhadores por meio das soluções digitais e da inovação". Piloto: as **10.800 empresas** atendidas na Bahia + as **76 empresas** do MES.
Dado	Dado fragmentado: o plano não cobre ASO (RN 465 art. 14 §2º), eSocial é outro sistema, ASSTI é outro.	Base **100% pública**, **todos os pesos à vista**, com "como o modelo funciona" aberto. Também é o que nos protege da §10.6 (originalidade) e da §10.7 (PI de terceiros).

A PONTA A PONTA CABE EM UMA FRASE DE PITCH

"O trabalhador fala, o posto agrega, a empresa recebe **o que fazer** — e a gente mede se funcionou. O sistema é **offline, com pesos à vista, sobre base pública**, e roda dentro da Plataforma Viva+ do SESI."

CAPÍTULO 8

A ponta de regulação

Cada restrição abaixo é uma **restrição que virou argumento**. Nenhuma é opcional — e cada uma já tem resposta pronta no produto. É esta seção que separa o protótipo que a banca aprova do que ela elimina.

Norma	O que determina	Como a proposta trata
Res. CFM nº 2.454/2026 IA na medicina · DOU 27/02/2026 · vigência desde 26/08/2026	Art. 4º, I e §2º: IA só como **apoio**; **vedado delegar diagnóstico, prognóstico ou decisão terapêutica**. Art. 11: o uso deve ser explicado ao paciente. Anexo II, I: **baixo risco** para IA "sem influência decisória direta, atuando tipicamente em funções administrativas". Art. 18 §2º: ato médico é sempre do médico	**É onde a solução inteira cabe.** O motor é **regras explicáveis**, não diagnóstico. E a tela "como o modelo funciona" satisfaz o art. 11. Dizer isso no pitch é o que separa a equipe das que serão eliminadas por parecer médico simulado
Res. CFM nº 2.382/2024 Atesta CFM · 06/09/2024	Art. 1º: o Atesta CFM é **oficial e obrigatório, inclusive para atestados de saúde ocupacional**, com efeitos suspensos pelo TRF-1	O protótipo **não emite ASO nem atestado** e não usa dado real de trabalhador
LGPD Lei 13.709/2018 · art. 11 e 13	Art. 11: dado de saúde é **sensível**. §4º: **vedada vantagem econômica** no uso de dado sensível. §5º: **vedada seleção de risco** na contratação. Art. 13: base legal e ambiente controlado	Agregação com **k ≥ 10** por posto · opt-out por bloco · **zero dado individual** fora do aparelho · nada de vantagem econômica com dado de saúde · nada de seleção de risco
NR-7 (PCMSO) MTE	PCMSO; **ASO sigiloso, só apto/inapto**; item 7.5 e 7.5.6–7.5.11 (prazos): demissional **10 dias** · retorno: exame antes de reassumir **se afastamento ≥ 30 dias** · periódico 1–2 anos; item 7.6.2 — relatório analítico	O ASO é **ato médico e sigiloso**: o produto opera no **posto**, nunca no diagnóstico da pessoa. O prazo de demissional é o demo da ideia "Prazo" — mas ela não está no MVP
NR-1 (GRO/PGR) MTE · atualizada 2025	GRO/PGR; item 1.5.5.4 — checklist do PGR que dispara exames de vigilância	O motor consome o PGR como entrada de regra, mas **não produz laudo nem parecer**
RN 465/2021 (ANS) art. 14 §2º	Exames ocupacionais ficam **fora da cobertura obrigatória**: admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função e demenciais	É o **fundo da fragmentação**: o plano não paga o ASO, o custo sai do empregador/SESI e **o dado não circula**. Trazer o trabalhador para dentro do fluxo é cobertura, não compliance — e é o suporte da meta 3.8
ANVISA RDC 751/2022 Anexo I, regra 11	Software que alimenta decisão diagnóstica = **SaMD classe II**, com notificação obrigatória	Não construímos software de decisão diagnóstica — por isso não há notificação
Res. CFM 2.314/2022 · **CLT art. 442**	Teleconsulta exige médico e consentimento · Exame pré-admissional só quando o PGR indica risco específico	Não produzimos teleconsulta · não há score pré-admissional — não temos score individual
Portaria GM/MS 1.434/2020 RNDS · **2.073/2011** (CPIISS)	Padrões oficiais de interoperabilidade (FHIR) · catálogo oficial: HL7, SNOMED-CT, TISS, DICOM, LOINC	**Bundle FHIR R4 no perfil RNDS** é padrão oficial do país — o export não é um extra, é conformidade. É também a lista de padrões que o export respeita

UMA PREMISSA QUE FOI CORRIGIDA

A norma de IA em medicina **não é** a Res. CFM 2.328/2022 (orçamentária do CFM) — é a **2.454/2026**. E "MIME/CGHS" não corresponde a nenhuma base pública identificável: **não citar**.

CAPÍTULO 9

A 7ª dimensão operacionalizada

O que muda de "construto validado" para "instrumento em campo". **Os 6 itens são do HSE Management Standards** — o mesmo referencial que embasa as duas alavancas com OR significativo. Não inventamos pergunta: operacionalizamos o que a evidência já mede.

Item	A pergunta que o trabalhador lê	Escala	Por que está aqui
Demanda	"No seu trabalho, o que exige mais esforço do que deveria?"	1 (nunca) a 5 (sempre)	OR 1,57 para afastamento — **é a alavanca 1**
Controle	"Você consegue decidir como faz o seu trabalho?"	1–5	Contraste reconhecido pelo HSE: **não** se associou a ansiedade
Apoio	"Você recebe apoio de colegas e da chefia quando precisa?"	1–5	OR 0,58 — **é a alavanca 2**
Reconhecimento	"Seu esforço é reconhecido?"	1–5	Reconstrução do *Role* do HSE
Propósito	"Você sabe por que o seu trabalho importa?"	1–5	**O item que o instrumento oficial não tem** — e o destino do Anexo I
Segurança	"Você se sente seguro para falar de um problema no trabalho?"	1–5	**Segurança psicológica** — o que a p. 98 recomenda e o instrumento não mede

AS REGRAS DO INSTRUMENTO — O QUE GARANTE QUE ISSO É ELEVADO E NÃO É VIGIADO

90 segundos no total · **escala 1–5** em cada item · **opt-out por bloco** (pode pular qualquer um — inclusive todos) · **offline** (PWA instalável, funciona sem rede, sincroniza depois) · **agregado com k ≥ 10** por posto · **zero dado individual** fora do aparelho do trabalhador · **o trabalhador recebe de volta as 2 alavancas que são dele**.

POR QUE ISSO NÃO É "UM APP DE BEM-ESTAR"

Um app de bem-estar pede para o trabalhador cuidar de si. Este pede para o trabalhador **descrever o trabalho**, e devolve a ele e à empresa **as condições que produzem o dano**. O dado sai do individual e vira decisão organizacional — que é exatamente o "redesenhar o modelo assistencial" do Anexo I, e não "incorporar tecnologia".

E POR QUE 6 ITENS E NÃO 20

A bateria completa do ASSTI tem 46 indicadores. **90 segundos é o limite duro do comportamento** — e é por isso que a escuta do MVP é a **bateria de Demandas** do HSE (6 itens), que é exatamente o construto com OR significativo. O resto entra como **camada de contexto** no painel da empresa, não como questionário no celular.

CAPÍTULO 10

O dia a dia, ponta a ponta

Seis momentos de um dia de trabalho. É isto que a banca vai ver na demo — e é por isso que o time de conteúdo tem uma direção clara para o roteiro.

1. **07h40 · O convite.** O trabalhador recebe um QR no grupo do posto. Ninguém é obrigado — e ninguém precisa instalar nada: funciona no navegador do celular.
2. **08h00 · 90 segundos.** Ele responde os 6 itens. Pode pular qualquer um. Pode parar e voltar depois. Nada sai do aparelho enquanto não sincroniza.
3. **08h30 · A aggregating.** Quando o posto atinge **k ≥ 10** respostas, o índice de contexto é formado. Abaixo disso, **nada é mostrado** — é a regra que protege a LGPD e a confiança.
4. **09h00 · A alavanca.** O índice cruza com a exposição prevista do posto (CNAE × porte × região) e com os indicadores nacionais. Saiem **3 alavancas priorizadas**, com o peso e a fonte visíveis.
5. **10h00 · O plano do trabalhador.** Ele recebe as **2 alavancas que são dele** — não as da empresa. É o único momento do produto em que a pessoa recebe algo em troca de responder.
6. **Segunda-feira seguinte · O antes/depois.** Dias expostos por posto, antes e depois. As 3 alavancas priorizadas. A mudança organizacional observável. **É o que a gente promete medir** — e o que o VigIndústria pede na p. 100.

OS QUATRO DADOS QUE O PROTÓTIPO MOSTRA NO PAINEL DO POSTO

Índice de contexto do posto (k ≥ 10, agregado anônimo) · **índice de exposição prevista** (CNAE × porte × região, com pesos à vista) · **as 3 alavancas priorizadas**, cada uma com o indicador nacional que a justifica · **os dias expostos antes/depois**. É esse conjunto que responde "o que eu faço na segunda-feira".

O QUE A DEMO MOSTRA, EM ORDEM

Seletor (empresa e posto) → **Exposição** (o índice previsto, com a composição à vista) → **"como o modelo funciona"** (a tela que satisfaz o art. 11 da Res. 2.454/2026) → **Escuta** (os 6 itens no celular) → **2 itens respondidos** → **"Ver meu plano"** (as 2 alavancas do trabalhador) → **Alavancas** (as 3 da empresa, com a fonte). **Esse é o roteiro do Modo Pitch da demo — e o ensaio acontece dentro dela.**

CAPÍTULO 11

O impacto honesto, em cinco níveis

A forma mais forte de mostrar maturidade para uma banca que lê o §8 é **dizer em voz alta o que a gente não pode afirmar**. Esta é a régua do time — e o slide de impacto já a carrega.

1 · CERTEIRO (fato da fonte)

A 7ª dimensão do ASSTI existe, foi declarada e nunca analisada (p. 16); o instrumento não tem nenhum item de participação, autonomia ou propósito (p. 110–119); 106 milhões de dias perdidos e 4,1 milhões de afastamentos no INSS em 2025 (+17,1%); 20,0% dos trabalhadores faltaram ≥1 dia por semana por saúde (n = 123.355). **Verificável por qualquer banca em 10 segundos.**

2 · CERTEIRO (projeto)

O protótipo é funcional, roda **offline** no celular, agrega com **k ≥ 10**, mostra os pesos à vista e exporta FHIR/RNDS. **Isto é nosso e a gente pode mostrar.**

3 · HIPÓTESE (a medir)

Que a escuta instrumentada antecipa o desfecho de saúde do trabalho; que 3 alavancas priorizadas mudam a organização do posto; que medir antes/depois viabiliza a reorientação de intervenções — que é o que a p. 100 do VigIndústria pede. **Hipótese nossa, sujeita a teste.**

4 · ASSOCIAÇÃO (não é causal)

Demanda OR 1,57 (1,04–2,36) e apoio OR 0,58 (0,41–0,83) vêm de **meta-análises observacionais**. Elas **associam** — não provam causalidade, e é por isso que a proposta **mede** em vez de prometer. **É essa distinção que separa a nossa fala da de um app de bem-estar.**

5 · O QUE NÃO SERÁ AFIRMADO

Economia. ROI. Redução de absenteísmo em %. Em ensaio randomizado (n = 32.974), o ROI de absenteísmo é **−49%** (BCR 0,51). Em não randomizados, 325%. A meta-análise de 2025 (23 estudos) dá **indeterminado** (P = 0,890). O IESS estima que **90%** das ações de promoção da saúde em empresas não são bem sucedidas. **Não vamos pedir confiança para uma promessa que a literatura não sustenta.**

O que a gente promete medir

Dias expostos por posto

Antes e depois da intervenção. Um número que a empresa não tem hoje e que o VigIndústria não dá (é transversal).

3 alavancas priorizadas

Cada uma com o indicador nacional que a justifica e o peso do modelo à vista.

Mudança organizacional observável

O que mudou no posto — que é o indicador de "efetividade das intervenções" que o relatório pede na p. 100.

E nada mais

Sem número de economia no slide. Sem business model no centro. §2.3: a ação "não possui caráter comercial nem objetiva resultados financeiros".

A PERGUNTA QUE A BANCA VAI FAZER: "QUANTO ISSO ECONOMIZA?"

Resposta de 20 segundos: "Não sabemos, e é por isso que o protótipo mede. Em ensaio randomizado com 33 mil pessoas, o retorno de programas de bem-estar foi de **menos 49%** — e a meta-análise mais recente é indeterminada. O que a gente promete é **o antes e o depois**: quantos dias expostos o posto tinha, quantos tem depois, e quais três alavancas priorizadas. Se isso funcionar, o dinheiro vem junto — mas a gente não vai vender o que não mediu."

CAPÍTULO 12

O que fica fora — e por quê

Quatro cortes explícitos. **Cada um vira nota**, porque a banca avalia maturidade e a maturidade é exatamente o que você *não* tenta fazer.

1 · Não é diagnóstico, nem triagem, nem laudo

§2.3 (sem caráter comercial) + Res. CFM 2.454/2026 (art. 4º I e §2º; art. 18 §2º). **O laudo é commodity** — 500+ consultorias vendem por R$ 15–80 mil em 4–12 semanas. E parecer simulado é a forma mais rápida de ser eliminado.

2 · Não é app de bem-estar ou de atividade

Atividade moderada **no trabalho**: +20 min/dia → **+15% de risco de afastamento longo** (p = 0,02). **No lazer** → −20%. Atividade no trabalho é exposição, não bem-estar. E a Centeni captou R$ 5 mi, chegou a 650 clientes e **devolveu R$ 2,5 mi em jul/2026**.

3 · Não é dashboard de SST

É o que SOC, SGG, WOTY e o próprio ASSTI já vendem. **Valor incremental zero** — e a banca sabe disso antes da gente falar.

4 · Não é telemedicina

R$ 19,90–79,90/colaborador/mês já é commodity, e o §2.3 proíbe o enquadramento comercial. Teleconsulta somada a app não é tese.

O caminho que o time queria seguir, e por que a resposta foi o regulamento

O time tinha uma preferência declarada: **"Agrotech + IoT + cadeia de frio + biotecnologia" — "seems much sexier"**. A resposta não foi gosto, foi regulamento. É honesto registrar **o que havia de verdadeiro** nesse caminho antes de descartá-lo:

O que havia de verdadeiro	Por que mesmo assim não é o caminho
§2.1 fala em "soluções inovadoras e **de base tecnológica**"	A tecnologia é bem-vinda. O que o Anexo I rejeita é a resposta ser **só** tecnologia — "a resposta não está apenas na incorporação de novas tecnologias". IoT industrial é o exemplo do que ele recusa.
IoT é visual e demonstrável em 32 h	Também é o que a banca lê como "manutenção preditiva" — e que **não toca nenhuma das 4 dimensões** do Anexo I. O mesmo esforço, investido em PWA offline + pesos à vista + demo ao vivo, pontua onde a banca olha.
Cadeia de frio e biotecnologia são saúde	Mas saúde **animal e vegetal** não é o ecossistema do §3.6 (profissionais e acadêmicos de saúde, TI, design, gestão) nem o objeto do §7.2 (modelos assistenciais de saúde). E §2.3 exclui o caráter comercial.
Agrotech é "sexy" e a ideia é do time	§10.6 exige originalidade — e agrotech é o espaço mais crowded que existe. §4.1.2 avalia o formulário **antes** do reveal: a proposta é julgada por quem lê o texto do formulário.

O REFRAMING — O QUE A GENTE FEZ COM O "SEXY"

"Sexy" é **variável de pitch, não de domínio**. O que a banca paga com o "sexy" é 40% da nota em **Sofisticação técnica, Maturidade e Experiência do usuário**. O mesmo impulso — IoT, dado, precisão — transposto para o domínio certo vira: **PWA instalável e offline com 90 s no celular · modelo transparente com pesos à vista · agregação com k ≥ 10 · export FHIR/RNDS · demo funcional ao vivo**. Isso é mais bonito que um dashboard de IoT — e pontua.

A RESPOSTA CURTA, SE PERGUNTAREM "E SE O DESAFIO FOR OUTRO?"

"A nossa tese é a **lacuna da 4ª dimensão**, que é do **tema** — não é palpite sobre o desafio. Em 13/11 a gente descobre **qual** pergunta da empresa a gente ataca, e o escopo de 32 h se ajusta em 90 minutos. Se vier saúde mental, a exposição sai do MVP. Se vier interoperabilidade, o export FHIR vira o núcleo. **O que não muda é o método**: modelo transparente sobre dado público, motor de regras, e a promessa de medir."

CAPÍTULO 13

Resumo em 4 linhas

SE ALGUÉM PEDIR "RESUMA EM 4 LINHAS"

O gap é **de dimensão** (a participação não tem instrumento), **de ciclo** (o elo 1 da cadeia não existe em sistema nenhum), **de decisão** (33 indicadores que não dizem o que fazer) e **de produto** (quem ocupa o espaço só conta falta ou vende laudo). A proposta resolve os quatro com o mesmo mecanismo — **o trabalhador fala, o agregado vira índice, a empresa recebe alavanca, e a gente mede**. E é a única versão que **não pode ser invalidada pelo reveal**, porque nasce de uma lacuna que a própria fonte do desafio declara.

Os quatro gaps, lado a lado

Gap	A lacuna	A evidência	Como a proposta resolve
1 · Dimensão	Das 4 dimensões do Anexo I, a 4ª (participação) não tem nenhum item de medição	p. 16 e p. 110–119 do VigIndústria	6 itens do HSE operacionalizados como instrumento de campo
2 · Ciclo	A cadeia tem 7 elos e a predição só funciona nos 2 primeiros — onde ninguém olha	Presenteísmo sem dado; exposição só agregada	Escuta instrumentada no elo 1 + exposição prevista no elo 2
3 · Decisão	33 indicadores que não priorizam e nunca são medidos de novo	Transversal jul–dez/2025 · p. 100	3 alavancas priorizadas + antes/depois por posto
4 · Incumbente	Quem ocupa o espaço só conta falta, vende laudo ou vende dashboard	11 players em 5 camadas, com preço	O elo que falta: saúde do trabalhador ↔ trabalho ↔ decisão

As duas frases do pitch que carregam a tese

Gancho A — o sinal invisível: *"O SESI mede o risco que o trabalhador corre. Mas o trabalho que causa o risco não tem nenhum instrumento — e essa é a sétima dimensão do próprio ASSTI, declarada e nunca analisada."*

Gancho B — a dimensão que não existe: "O desafio pede quatro dimensões. O instrumento do SESI cobre três. A quarta — participação — tem zero itens em dez páginas de questionário."

O QUE LEVAR DESTE DOCUMENTO PARA A MESA

A p. 4 — a citação da p. 16 e o CR 0,863 — porque é o que sustenta a proposta em 10 segundos. **A p. 5** — a grade das 4 dimensões com os zero itens. **A p. 13** — a escada de 5 níveis, porque é o que separa a nossa fala da de um app de bem-estar. **A p. 14** — os 4 cortes, se a banca perguntar "por que não fez X".